

Aktuaalsed teemad Saksamaa sotsiaaltöö poliitikas, hariduses ja kutsetegevuses



Peter Erath, Dr. Dr. h.c.

*sotsiaaltöö teooria professor, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Saksamaa)
sotsiaaltöö külalisprofessor, Ostrava riiklik ülikool (Tšehhi)*



Jutta Harrer

*sotsiaaltöö teooria lektor, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
õppejuht, noorte heaolukeskus Caritas-Kinderdorf Marienstein Eichstättis*

Saksamaal on sotsiaaltöö positsioon praegu väga vastuoluline. Ühest küljest võib seda lugeda äärmiselt tugevaks, eriti kui arvestada, et aastatel 2015 ja 2016 saabus riiki enam kui miljon pagulast ja varjupaigataotlejat. Tuli palgata suur hulk sotsiaaltöötajaid ning on tekkinud puudus sotsiaaltöötaja kandidaatidest. Teisalt on sotsiaaltööl vaid üksikutes valdkondades õnnestunud selge tõendusmaterjaliga tõestada oma produktiivsust ja tõhusust nii valdkonna sees kui ka väljaspool.

Andmed ja poliitika

Saksamaal on ligikaudu 82 miljonit elanikku, sotsiaaltöö alal tegutseb 258 000 inimest, kellest 46% töötab osalise tööajaga. Need arvud on piirkonniti kõikumad, kuid paradoksaalsel kombel tundub, et mida jõukama piirkonnaga on tegemist, seda rohkem on

seal sotsiaaltöötajaid. Seega paistab sotsiaalvaldkonna elukutsete seas sotsiaaltöö hoidvat tugevat positsiooni. Praegustele sotsiaaltöö tudengitele on kindlustatud väljavaade töötada omal erialal.

Et saada ülevaade Saksamaa sotsiaaltööst, on oluline teada, et ligikaudu 80% kogu sotsiaalvaldkonna tegevusest korraldatakse ja teostatakse mittetulundusühingute ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu. Eraettevõtted (5%) ja riiklikud organisatsioonid (15%) on selgelt vähemuses ja tegutsevad ainult kindlates valdkondades. **Subsidiaarsuse** kui juhtiva poliitilise põhimõtte raamistikus¹ on kesksel kohal kuus suurt eraalgatuslikku hoolekandeorganisatsiooni: Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Der Paritätische, Deutsches Rotes Kreuz ja Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.

¹ Riik ja kohalikud omavalitsused pakuvad hoolekandeteenuseid ainult juhul, kui tuge ei ole võimalik saada pereliikmetelt, sõpradelt või mõne eraalgatusliku organisatsiooni kaudu – toim.

Neist igäihe omanäoline struktuur hõlmab erisuguse taseme organisatsioone ja enesest mõistetavana näeb ette ka vabatahtlike tegevust, mis paratamatult mõjutab (mõnikord ebasoodsalt) osutatavate teenuste kvaliteeti. Hoolekandeorganisatsioonid tegutsevad nii piirkonniti kui ka riigi tasandil, mistõttu on nende mõju riiklikule ja kohalikele (sotsiaal-)poliitikale märkimisväärt. Suhteliselt madala juhtimisvõimekusega kohalikud omavalitsused peavad paratamatult nende tugevate ja äärmiselt mõjukate hoolekandeorganisatsioonidega arvestama (Jüster 2015).

Alates 1990. aastatest võib sotsiaaltööd kirjeldada kui halduspraktikat uue juhtimismudeli raamistikus, mida tihti nimetatakse **uueks avalikuks halduseks** (ingl *New Public Management*) (Eichhorn 2005). Selle mudeli eesmärk on ära hoida bürokraatlike struktuuride vohamist kohalikes omavalitsustes, pannes enam rõhku turupõhisele teenuste pakkumisele. Sellega püütakse vältida võimalikku tõhususe kadu, mis kaasneb haldus- ja korralduslike toimingutega. Kesksed juhtimisinstrumendid on:

- kõigi asutuste ja teenuste tsentraliseeritud planeerimine üldise sotsiaalplaneerimise raames
- kõigi kulutuste sidumine **eelarvetega**, et ära hoida kulutuste suurenemist ja raha raiskamist
- kvaasituruloomine, et fikseerida hinnad **hoolekande segamudeli** (ingl *welfare-mix*) abil²
- **lepingute haldamise ja kontrolli** meetodite kasutusele võtmine, et juhtida kvaliteeti igas organisatsioonis (Eichhorn 2005).

Haridus

Kuna väljavaade saada erialast tööd on palju-
tõotav, on noorte huvi sotsiaaltöö õppimise

vastu märgatavalt kasvanud. Saksamaal on võimalik õppida sotsiaaltööd bakalaureuse tasemel 132 õppekava alusel: 2015/2016. aasta talvesemestril oli sotsiaaltöö üks 20 populaarsemast erialast; sotsiaaltööd õppis 43 000 üliõpilast, neist 32 000 naissoost.

Sotsiaaltöö õpingud pakuvad mitmekülseid võimalusi. Esimene tase on bakalaureuseõpe. Üldjuhul on tegemist laiapõhjalise üldsotsiaaltöö kursusega, mis kestab 3,5 aastat ning ei näe ette spetsialiseerumist. Magistrantuuris on kahte tüüpi õppekavad: **järjestikõppe** kursused, mille eesmärk on saavutada kõrgem teoreetiline ja meetoodiline tase, ning **edasiõppe** kursused, mille eesmärk on süvendada teadmisi eri sihtrühmadest, töövaldkondadest ja sotsiaaltöö puhul tegelikult olulistest praktilistest meetoditest. Ainult veerandil neist kursustest on üldsotsiaaltöö suunitlus. Lisaks täiskoormusega õppele on sotsiaalvaldkonnas töötavatel inimestel võimalik õppida magistriõppes osalise õppeajaga ning siduda õpingud otseselt oma töövaldkonnaga (Erath ja Balkow 2016, 405).

Üldiselt on sotsiaaltöös olemas ka doktoriõppe võimalus. Sellele vaatamata ei ole Saksa rakendusteaduste ülikoolidel õigust oma üliõpilastele doktorikraadi välja anda. Seega tuleb üliõpilastel, kes pürgivad doktorikraadi poole, valida mõni teine enam-vähem sobiv õppekava ning läbida doktoriõpingud, combineerides sotsiaaltööd mõne lähedase erialaga, nagu nt sotsioloogia, hariduse, psühholoogia või sotsiaalpoliitikaga (*ibid* 412).

Pidades silmas, et programme erinevused on väga suured, bakalaureuse- ja magistritaseme õppekavad ei ole omavahel kooskõlas ning sotsiaaltöö doktoriõppekavu on vähe, ei ole ülikoolides sotsiaaltööst siiani eraldi teadusala kujunenud. Samas ei ole ka tugevat erialaorganisatsiooni, mis aitaks sotsiaal-

² Avalik sektor reguleerib turgu, ostes hoolekandeteenused riigihankega sisse – toim.

tööd kui praktilist elukutset akadeemilise distsipliiniga ühendada. Praegu kuulub vaid 6000 sotsiaaltöötajat Saksamaa sotsiaaltöö erialaliitu DBSH (*Berufsverband Sozialer Arbeit in Deutschland*) (vt DBSH 2017).

Valitud töövaldkonnad

Saksa sotsiaaltöötajad töötavad eri valdkondades, alustades laste ja noorte hoolekande, tervishoiuteenuste ning eakate hooldusega ja lõpetades sotsiaalmajandusliku sektoriga. Artikli selles osas käsitleme mõningaid töövaldkondi. Arvestades tänaseid suundumusi sotsiaalvaldkonna arengus, seadusemuudatusi ning esile kerkivaid sotsiaalseid probleeme jm tegureid, on neli järgnevalt käsitletud valdkonda muutunud eriti tähtsaks.

Laste ja noorte hoolekanne

Laste ja noorte hoolekanne hõlmab rohkesti eri töövaldkondi. Lisaks teenustele, mis on mõeldud kõigile lastele ja noortele (laste- ja noortekeskused, vaba aja keskused, tegevused noortele koolivaheaegadel), noorsootööle (koolides, tänaval, välinoorsootöö) ja noorte osalusel toimuvale kultuuritööle (tantsimine, teater, kontserdid jne), kuulub siia ka suur hulk hoolekandeteenuseid, mille eesmärk on toetada vanemaid, kel on raskusi oma laste ja noorte kasvatamisel (saksa k *Hilfen zur Erziehung*), nt tugirühmad, hoolduspered, laste asenduskodud. Asjakohane õigusraamistik on fikseeritud Sotsiaalõiguse VIII Raamatus (*Sozialgesetzbuch VIII*).

Tänapäeval on just haridusalase toe valdkonnas eesmärgiks „suur lahendus”, mis näeb ette suuremaid õigusi vanematele või lastele, kui nad taotleavad nt tugispetsialistide abi hariduse omandamisel või puudega lastele ja noortele mõeldud täiendavalt rahalisi toetusi (saksa k *Behindertenhilfe*). Peetakse vajalikuks suurendada teenusekasutajate õigusi ning hakata pakkuma individuaalseid

teenuspakette **isikliku eelarve** vormis. Sellise korralduse puhul saab teenusekasutaja ise kokku panna pakutavast valikust endale sobiva teenuste paketi. Kuid selline ulatuslik muudatus on traditsiooniliste teenusepakujate jaoks keeruline, sest nemad pakuvad klientidele tihti vaid valmis kujul tooteid (nt programme, spetsiifilisi teenuseid) ning ei taha (või ei ole võimelised) neid teenuseid inimese järgi kohandama. Käesolev debatt on kutsunud esile hoolekandeorganisatsioonide vastuseisu ning ei ole veel selge, kas valitsusel õnnestub kehtestada seadusemuudatused, millega laiendatakse teenusekasutajate isiklike õigusi. (Igfh 2017).

Kriminaalhooldus, taasühiskonnastamine

Kriminaalhooldusest ja resotsialiseerimisest on kujunemas üks olulisemaid sotsiaaltöötajate töövaldkondi. Selle töö eesmärk on aidata inimesi, kes on sattunud keerulisse olukorda, nagu nt õigusrikkujaid, narkosõltlasi, koduta ja/või psüühilise erivajadusega inimesi. Klugi (2003, 11) sõnul võib taasühiskonnastamist käsitleda kui sekkumist kliendi eluolukorda või -faasi eesmärgiga juhendada inimest olukorras, kus ta ei ole võimeline oma elu ise korraldama ning vajab seetõttu välist abi.

Selliseid sekkumisi rakendatakse tihti sunniviisiliselt. Enamiku teenusekasutajate motivatsioon on üsna madal, seetõttu ei ole sotsiaaltöötajate töötingimused selles valdkonnas sugugi kerged. Lisaks ei ole tihti võimalik korraldada klientidele rahalist abi. Seetõttu on töö eesmärk pakkuda klientidele n-ö madala lävega teenuseid, sealhulgas nt kohvikud ja öömajad koduta inimestele, koolitusprogrammid motivatsiooni suurendamiseks või agressiivsuse vähendamiseks jne. Sotsiaaltöötajad peavad olema väga vilunud klientide motiveerimisel ning valdama asjakohaseid sotsiaaltöö meetodeid ja tehnikaid.

Tervishoid/rehabilitatsioon

Selles valdkonnas on eriti oluline tahe ja oskus töötada interdistsiplinaarsetes meeskondades. Peamiseks ülesandeks on teha koostööd arstide, psühholoogide jt spetsialistidega. Põhilised tööloigud on nõustamine ning probleemi- ja lahenduspõhised vestlused patsientidega, pereliikmete vaheliste konfliktide lepitamine ning koos klientidega abiprotsesside planeerimine ja korraldamine. Et **sotsiaalse diagnoosi** kindlaks määramiseks on välja töötatud põhjalik protseduur, on haiglasotsiaaltöö väga levinud ning Saksamaal kõrgelt hinnatud. Kliinilise ja rehabilitatsioonitöö olulised meetodid on ka juhtumi ja hoolduse korraldus, ravi planeerimine, võrgustiku analüüs ja võrgustikutöö, samuti kriisisekkumine ja rühmatöö (vt Gahleitner ja Hahn 2008).

Migratsioon

Suure hulga põgenike ja varjupaigataotlejate tõttu on migratsioonist saanud viimastel

aastatel väga oluline töösektor. Valdkonna keerulisuse tõttu on töös palju probleeme. Selles valdkonnas töötades on äärmiselt tähtis omada põhjalikke õigusalasid teadmisi, samuti teadmisi asjaajamisest ja seadusega ette nähtud võimalustest, et pakuda migrantidele ja varjupaigataotlejatele pädevat tuge asjakohaste informatsiooni- ja nõustamisteenuste näol. Lisaks on vaja mitmesuguseid kompetentse, et toime tulla kultuurierinevusi arvestava suhtlusega ja ära hoida rassistlikud suhtlustrid, seda nii immigrantide kui ka kohaliku elanikkonna hulgas. Sotsiaaltöötaja peab oskama neid mustreid murda nii koolitusprogrammide kui rühmaarutelude kaudu, et luua eeldused inimõiguste ja -väärikuse paremaks mõistmiseks ning mitmekesisuseks õiglasel ja ausal kogukonnas (vt Polat 2017).

Jätkub järgmises numbris

Tõlge: Tiido ja Partnerid keeleagentuur / ajakiri Sotsiaaltöö

Viidatud allikad

- Jüster, M.** (2015). Die verfehlte Modernisierung der freien Wohlfahrtspflege. Eine institutionalistische Analyse der Marktwirtschaft. Baden-Baden: Nomos.
- Eichhorn, P.** (2005). Ökonomische Herausforderungen an soziale Dienste in Europa. Raamtus: Linzbach C. jt (toim.): Die Zukunft der Sozialen Dienste vor der Europäischen Herausforderung. Baden-Baden: Nomos, 106–113.
- Erath, P., Balkow, K.** (2016). Einführung in die Soziale Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer.
- Flückinger, C., Wüsten, G.** (2015). Ressourcenaktivierung. *Ein Manual für Psychotherapie, Coaching und Beratung*. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.
- DBSH e. V.** (2017): Mitgliederzahlen. www.dbsh.de/der-dbsh.html (06.10.2017).
- Igfh e. V.** (2017): Information zur Reform SGB VIII – Vorbereitung eines neuen Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen. www.igfh.de/cms/nachrichten/informationen-zur-reform-sgb-viii-%E2%80%93-vorbereitung-eines-neuen-gesetzes-zur-st%C3%A4rkung-von (06.10.2017).
- Klug, W.** (2003). Mit Konzept planen – effektiv helfen. *Ökosoziales Casemanagement in der Gefährdetenilfe*. Freiburg: Lambertus.
- Gahleitner, B., Hahn, G.** (2008). Klinische Sozialarbeit: Gefährdete Kindheit – Risiko, Resilienz und Hilfe. Köln: Psychiatrie Verlag.
- Polat, A.** (2017). Migration und Soziale Arbeit. *Wissen, Haltung, Handlung*. Stuttgart: Kohlhammer.